儿童青少年焦虑自助干预小程序

产品设计方案

测评工具：儿童焦虑性情绪障碍筛查表（SCARED）中文版 · 干预取向：认知行为取向的低强度自助干预 · 文档日期：2026 年 10 月 24 日

一、产品定位

本产品设计为**按焦虑类型分流的自助干预程序**，而非情绪测评或倾诉社区。它由三段闭环构成：先用标准化量表定位使用者属于哪一类焦虑表现，再按类别进入结构化的分级或分步练习，最后以同一量表复测对照水平变化。测评在链路中的角色是"选择干预路径"和"监测变化"，不是给用户贴标签。

之所以强调"自助干预"，是因为仅有测评和建议文本不足以产生可测量的改变。认知行为取向的低强度干预要求具备结构化疗程、主动练习与作业、执行反馈以及常规结果监测，本方案按该要件搭建。

二、测评工具与计分口径

采用 SCARED 中文版，共 41 个条目，按最近三个月的实际感受以 0～2 三级计分（0 没有此问题、1 有时有、2 经常有），总分范围 0～82 分，得分越高提示焦虑表现越明显。五个分量表的条目组合与满分如下。

分量表	条目序号	项数 / 满分	指向
躯体化 / 惊恐	1, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 34, 38	13 / 26	惊恐发作样躯体反应与回避
广泛性焦虑	5, 7, 14, 21, 23, 28, 33, 35, 37	9 / 18	过度担忧、追求表现、难以放松
分离性焦虑	4, 8, 13, 16, 20, 25, 29, 31	8 / 16	离开家或主要照护者时不安
社交焦虑	3, 10, 26, 32, 39, 40, 41	7 / 14	被注视、与人交往时的紧张回避
学校回避	2, 11, 17, 36	4 / 8	上学相关情境的不适与抗拒

总分界值。采用双口径并同时呈现：中国城市常模以总分第 80 百分位（**≥23 分**）为划界分，灵敏度 74%、特

异度 79%；国际常用口径为**总分 ≥25** 提示可能存在焦虑障碍，**30 分以上**特异性更高。界面在结果页同时标注所落区间，避免单一阈值造成误读。

> **分量表界值的处理。**各来源给出的分量表临界值不一致，本程序不套用未经统一的分量表界值，而是以**得分率（分量表分 ÷ 该量表满分）**排序来确定优先干预的板块。这一取舍在界面上向使用者明示，也便于答辩时说明依据。

三、分流规则

测评提交后计算五个分量表得分率并降序排列，得分率最高者判定为**主板块**，在板块列表中置顶并标注"推荐"；其余四个板块保持开放，不锁死。得分率并列时以分量表原始分高者优先。学校回避分量表仅 4 项，满分 8 分，得分率容易被放大，因此在推荐判定时与总分（≥23 或 ≥25）联合参考，低总分且学校回避得分率高的情况按"先了解环节、不急于贴类型"处理。

四、五个自助板块

4.1 忧管解难 对应广泛性焦虑

核心机制是把全天弥散的担忧收拢到固定时段，再逐步缩短担忧占用注意的时间。分四级，每级约持续一周，本级坚持满 5 天即可进入下一级，任一级别做不到时可退回上一级再练一周，退回同样写入记录。

级别	本级目标与操作	进入下一级的条件
一级 把担忧推到固定时间段	开始前必须先设置一个每日固定时段（含时长，默认 15 分钟）。其余任何时间冒出担忧，只记一句话，推迟到该时段集中处理；时段内能解决的写一步，不能解决的划掉。	坚持 5 天，且已设置时段
二级 担忧出现时立马打断	不推迟、当场中断。打断动作要求具体且带动身体，例如心里喊"停"、起身走两步、凉水洗手、说出眼前五样东西。中断后立即给手上一件事。	坚持 5 天，选定打断动作
三级 做任务时能停止并回到任务	在普通任务（作业、整理、家务）中出现担忧，停下担忧、指出下一个最小动作、立刻去做。担忧可以存在，但人在做事。	坚持 5 天，写明本周守住的任务

四级 压力任务中也能停止并回到任务	升级到高压场景（限时作业、考试、被提问、当众发言）。难度最高，做不到不代表失败，退回三级再练一周即可。	完成后进入复测提示

4.2 检期践行 对应社交焦虑

以行为实验为骨架：把"别人会盯着我的失误"这一预测变成可检验的假设。五步顺序固定，前一步未完成不解锁下一步。

步骤	操作内容
1 选择安全社交情境	挑代价小、有回应把握的场景，并写明为何认为它安全，不直接选最难的那个。
2 写出担心的结果	把"会发生什么"写具体，同时给出它发生的概率（0–100）与当前焦虑程度（0–10）。
3 设计难度较低的小行动	只写一个可执行动作，小到一个念头就能做完，不写目标、不写标准。
4 尝试	做完即记录：做了／做了一半／没做但留在现场；过程焦虑程度；实际发生了什么（只写事实）。
5 比较预期与实际	对照第 2 步的预测与概率，标注担心结果是否出现，并写下一条本轮发现。

> **板块内置的告知内容。**他人的注意并没有过度聚焦在使用者身上，旁人多数时间在关注自己接下来要说什么。界面把这一点写成可检验的表述，并指向"把预测与实际放在一起比"这一动作，而不是当作安慰话术。

4.3 分忧计划 对应分离性焦虑

五步推进，其中第 3、5 步要求可信成人参与，板块顶部固定提示需要家长或照护者同行。

- **说清担忧**：把"不想离开"背后那句具体担心写出来，并描述脑中最清楚的画面。
- **确认环境安全**：逐条核对可核实的安全条件（能否联系到家人、所在场所有无可信成人、是否已把担心告诉大人），核对不上的条目单独列出，留待向成人确认。
- **与可信照护者商定适龄小目标**：由使用者与成人共同确定一个年龄合适、有可能成功的分离小目标，并记录成人的建议与调整。
- **尝试**：记录结果（顺利完成／完成一部分／中途求助／未试），以及分开前与过程中的最高焦虑程度、

使用过的应对办法。

- **共同调整**：与成人一起回看，保留顺利的部分，把目标校准到下次做得到的难度。

4.4 识身应变　对应躯体化 / 惊恐

- **记录感觉及情境**：以多选方式勾选身体反应（心跳加快、呼吸困难、头晕、手抖、出汗、恶心、不真实感、失控感），并记下当时所处情境与难受程度。
- **学习焦虑与身体反应的关系**：说明"战斗或逃跑"反应被启动时肾上腺素带来的心跳、呼吸与消化变化；要点在于这些感觉极其难受但本身不危险，真正放大恐惧的常是"我是不是要出事了"这个解释。使用者需用自己的话写下一句"我原以为是____，其实是____"。
- **尝试舒适自然的呼吸与放松**：不要求刻意深吸，以舒适节律让呼气长于吸气，配可动效的引导圈完成 3 轮；界面明确写着出现头晕或不适加重即刻停止、恢复自然呼吸。
- **记录体验**：练前与练后各打一次难受程度分，选择最有效的环节，自动给出下降幅度。

4.5 溯因支持　对应学校回避

不先处理"去不去"，先把最难的环节、支撑因素和支持者定位出来。

- **找出最困难的上学环节**：从起床出门、进校门、第一节课、课间午休、食堂、被老师提问、考试、放学等待等节点中勾选，并锁定最难的一项。
- **了解同伴、学习、身体等因素**：多选同伴关系紧张或被孤立、被欺负或起哄、功课跟不上、被老师批评、在校躯体不适、睡眠不足、家庭因素、说不清，可补充说明。
- **选择可信成人**：确定告知对象、拟好第一句话、约定说出口的时间。
- **共同制定支持步骤**：与成人一起写三步，第一步须小到明天即可完成，并写明各环节由谁配合。

> **板块强制提示。**若不想上学的原因涉及校园霸凌、被威胁或孤立、明显的学习困难、教师不当对待或身体疾病，仅靠使用者自行调整并不足够，需要寻求专业支持：告知家长与信任的老师，联系 12355 青少年服务台；人身安全受到威胁时立即拨打 110。界面同时说明"这不是告状，而是把应由成人承担的责任交回去"。

五、记录与复测闭环

每个板块的每一次操作都产生记录：忧管解难保留每日打卡与晋级、退回事件，其余板块逐步保存填写内容。

所有条目汇入统一的练习时间轴，可看到"哪天在哪个板块做了哪一步"。任一板块的步骤走完即弹出复测引导，建议当时或一周后用同一量表复测；"我的记录"页给出首测与最近一次测评的对照表，总分与五个分量表分别标注升降，使"水平变化"可指认。界面同时提示两次测评间隔建议不短于一周，以免分数波动主要来自当天状态。

六、界面结构

页面	内容
自评	量表作答与结果。结果页呈现总分、双口径界值、五个分量表的得分条与得分率，并给出推荐板块。
板块	五个板块入口卡片，标注所对应分量表的本次得分、进度点位与推荐标记；进入后为该板块的阶梯或步骤列表，未解锁项置灰并说明原因。
板块详情	逐级／逐步展开的操作面板：说明、必须项（如时段设置）、当天打卡、完成记录、退回上一级。
我的记录	水平变化对照表、四级进度、练习时间轴、板块得分对比、量表与界值说明、隐私与监护人说明、求助渠道、清空数据。

七、合规与安全设计

1. **适用范围与监护人知情**：SCARED 适用于 8～18 岁自评。未满 14 周岁处理个人信息需取得父母或其他监护人同意，因此首次进入设置"开始前请看一下"环节，明确适用年龄、结果用途与"建议把结果给一位信任的大人看"，同意后才进入作答。
2. **表述边界**：全链路常驻"本测评仅供自我了解，不构成医学诊断"。界面不使用诊断、筛查确诊、治疗、疗效、"你患有"等表述；等级词统一写成困扰程度，避免读起来像临床分级结论。
3. **危机与转介通路**：作答与练习填写内容均做敏感表述检测，命中即跳过常规流程，直接呈现 12356 全国心理援助热线（24 小时、免费、匿名），紧急情况指向 120 与就近急诊；SCARED 第 9 项（不如死去或伤害自己的念头）只要不为 0 即触发安全提示，不受总分高低影响。学校回避板块内置霸凌与学业困难的转介提示。
4. **数据与匿名**：仅收集自评答案与练习填写内容，用途限于生成个人结果与练习记录；不采集手机号、身

份证、位置、通讯录。数据保存在使用者设备本地；若后续同步后端，身份标识仅在服务端用于判断归属，不在任何界面出现。本版本不含公开社区、评论与发帖功能，因此不触发电子公告服务类的专项要求，也回避了社区类目与后台实名的合规负担。

5. **干预强度分级**：得分处于较低区间时以自助练习与维持为主；达到或超过划界分时，练习仍可使用，但反馈与提示一律优先导向专业评估，不让自助练习替代就诊。

八、待确认事项

- 五个板块的每级时长与晋级天数是否统一为 5 天，或按低龄段放宽到 4 天。
- 分忧计划、溯因支持两板块是否需要家长侧的独立视图，以便成人看到需要配合的条目。
- 复测间隔（一周、两周或自定义）与是否允许在两次测评之间重做测评。
- 正式落地形态：小程序、网页还是校内终端；涉及的用户主体类型与服务备案要求需在上线前确认。

参考文献

1. Birmaher B, Khetarpal S, Brent D, et al. The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): scale construction and psychometric characteristics. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1997;36(4):545-553.
2. Birmaher B, Brent DA, Chiappetta L, et al. Psychometric properties of the SCARED: a replication study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1999;38(10):1230-1236.
3. 王凯，苏林雁，朱焱，等．儿童焦虑性情绪障碍筛查表的中国城市常模．中国临床心理学杂志．2002;10(4):270-272．
4. Su L, Wang K, Fan F, et al. Reliability and validity of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) in Chinese children. J Anxiety Disord. 2008;22(4):612-621.
5. Shafran R, et al. The concept and definition of low intensity cognitive behaviour therapy. Behav Res Ther. 2021.
6. Cognitive Behaviour Therapy 关于指导式自助（guided self-help）实施与督导要点的指南类研究，2024.

> 本方案所述量表界值、信效度数据均来自上列文献与量表原始资料；产品界面中的干预步骤为自助练习设计，不构成诊疗建议。本测评仅供自我了解，不构成医学诊断。